

# अति सक्रिय मूत्राशय (OAB)

WARWIKI

रोगी जानकारी · अचानक तीव्र इच्छा, बार-बार जाना, और रिसाव को समझें

अति सक्रिय मूत्राशय (OAB) एक सामान्य और इलाज योग्य स्थिति है जिसमें मूत्राशय की मांसपेशी बिना वजह सिकुड़ने लगती है। इससे अचानक तीव्र पेशाब की इच्छा, बार-बार जाना, रात में उठना, और कभी-कभी शौचालय पहुँचने से पहले रिसाव होता है। यह बुढ़ापे का सामान्य हिस्सा नहीं है — इसे सुधारने के कई तरीके हैं।

## इस स्थिति के बारे में

सामान्यतः मूत्राशय शांति से भरता है और भरने पर संकेत देता है। OAB में मूत्राशय बहुत जल्दी या बहुत तेज़ "urgent" संकेत भेजता है। मुख्य लक्षण हैं:

- **पेशाब की तीव्र इच्छा (Urgency)** — अचानक, रोकना मुश्किल
- **बार-बार पेशाब (Frequency)** — दिन में लगभग 8 से अधिक बार
- **रात में पेशाब (Nocturia)** — सोते समय उठना
- **तीव्र इच्छा असंयम (Urge leakage)** — शौचालय पहुँचने से पहले रिसाव

## कारण

अक्सर कोई एक कारण नहीं होता — यह मूत्राशय और मस्तिष्क के बीच संकेतों की समस्या है। इसे बढ़ाने वाले कारण हैं: **caffeine और alcohol**, कब्ज, अधिक वज़न, कुछ दवाएँ, और महिलाओं में menopause। मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI) भी यही लक्षण दे सकता है, इसलिए पहले उसे जाँचा जाता है। कभी-कभी तंत्रिका की समस्या भी जुड़ी होती है।

## शब्दों को समझें

### अति सक्रिय मूत्राशय (OAB)

मूत्राशय के जल्दी सिकुड़ने से तीव्र इच्छा और बार-बार पेशाब।

### Urgency

अचानक, तेज़ पेशाब की इच्छा जिसे रोकना मुश्किल हो।

### Frequency

दिन में कई बार पेशाब जाने की ज़रूरत।

### Nocturia

रात को सोते समय पेशाब के लिए उठना।

### तीव्र इच्छा असंयम

तेज़ इच्छा के साथ पेशाब का रिसाव।

### Bladder diary

पेय पदार्थ, शौचालय यात्राएँ, और रिसाव का सरल रिकॉर्ड।

### पेल्विक फ़्लोर

वे मांसपेशियाँ जिन्हें train करके मूत्राशय नियंत्रण सुधारा जा सकता है।

### मूत्राशय प्रशिक्षण

यात्राओं के बीच समय धीरे-धीरे बढ़ाकर urgency कम करना।

**क्या यह ठीक होगा?** हाँ — अधिकांश लोगों में सुधार होता है। इलाज सरल बदलावों और मूत्राशय प्रशिक्षण से शुरू होता है और ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़ता है। फ़र्क नज़र आने में कुछ हफ़्ते लग सकते हैं — हर कदम को समय दें।

### जाँच कैसे होती है

- लक्षणों की चर्चा और **bladder diary**
- संक्रमण या खून की जाँच के लिए **urine test**
- मूत्राशय खाली होने की **scan** जाँच
- अगर तस्वीर अस्पष्ट हो तो urodynamics या scope test

### इलाज कैसे होता है (चरणबद्ध)

- 1 **जीवनशैली & प्रशिक्षण** — caffeine/alcohol कम करें, तरल पदार्थ संतुलित रखें, कब्ज दूर करें, वज़न घटाएँ; **मूत्राशय प्रशिक्षण** और **पेल्विक फ़्लोर व्यायाम (केगेल)** करें।
- 2 **दवाएँ** — मूत्राशय की मांसपेशी को शांत करने वाली गोलियाँ।
- 3 **उन्नत विकल्प** — मूत्राशय में **Botox**, या **नर्व स्टिमुलेशन** (PTNS या sacral neuromodulation)। इनके अलग handout उपलब्ध हैं।

### OAB के साथ जीना

- कुछ दिन **bladder diary** रखें — triggers पहचानें।
- तरल पदार्थ धीरे-धीरे पिँ; इतना कम न करें कि पेशाब गाढ़ा हो जाए।
- **तय समय पर जाएँ** और "urge-control" तकनीक इस्तेमाल करें — रुकें, पेल्विक फ़्लोर दबाएँ, साँस लें, फिर जाएँ।

#### यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- पेशाब में **खून**, या पेशाब करते समय दर्द या जलन
- बुखार, या पीठ/बाजू में दर्द (संभावित संक्रमण)
- अचानक **पेशाब बिल्कुल न होना**

#### याद रखने योग्य तीन बातें

1. OAB — urgency, frequency, रात में उठना, और कभी-कभी रिसाव — सामान्य और इलाज योग्य है, बुढ़ापे का हिस्सा नहीं।
2. इलाज चरणबद्ध है: पहले जीवनशैली और मूत्राशय प्रशिक्षण, फिर दवाएँ, फिर Botox या नर्व स्टिमुलेशन।
3. Bladder diary triggers पहचानने में मदद करता है; पेशाब में खून, दर्द, बुखार, या पेशाब न होने पर तुरंत टीम को बुलाएँ।